

Hemorragia digestiva alta · abordagem

HDA = sangramento proximal ao Treitz (hematêmese, melena, tipicamente). Estabilize volume, inicie IBP e defina timing da EDA conforme gravidade e estigmas de risco.

Úlcera vs variz

Dica - Úlcera vs variz

Sempre pergunte hepatopatia/álcool/hipertensão portal. Varizes: terlipressina/octreotide + ATB profilático + EDA. Úlcera: IBP em infusão/alta dose + EDA com terapia se Forrest de risco.

Fluxo: vias aéreas/volume !' IBP ± vasoativo na variz !' EDA diagnóstica e terapêutica.

HDA na emergência

Ressuscitar -> IBP -> endoscopia

ABC + volume

2 acessos / sangue

IBP +/- terlipressina

ulcera vs variz

EDA precoce

diagnostico + terapia

Passos iniciais

- Via aérea se hematêmese maciça / rebaixamento; O₂ e monitorização
- Volume e hemoglobina alvo prudente (evitar transfusão liberal no estável)
- Corrigir coagulopatia conforme contexto; suspender anticoagulante com critério
- EDA preferencialmente nas primeiras 24 h; mais cedo se instável após ressuscitação

Forrest (ideia de risco)

Classificação | Risco / ideia

Ia / Ib | Sangramento ativo — terapia endoscópica

Ila | Vaso visível — alto risco, terapia

Ilb | Coágulo aderente — avaliar remoção/terapia

Ilc / III | Manchas / base limpa — baixo risco

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Melena não é 'só HDB'. Sangue digerido de HDA é causa clássica. Hematêmese/HNIA alta + instabilidade !' trate como HDA até prova em contrário.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1